3.血栓性外痔：**剧痛、暗紫色肿块→剥离痔内血栓**



4.内痔 齿状线以上为黏膜(易破裂出血)

（1）分度（空挡-自动挡-手动挡-挡坏了）

I出血（鲜血）

II出血+脱出（可自行还纳）

III出血+脱出（需 ttsx 用手还纳）

IV出血+脱出（不能还纳或还纳后再次脱出）

（2）内痔多没有疼痛，若伴血栓、嵌顿、感染可疼痛

有疼痛不能排除内痔

（3）**截石位 3、7、11 点**（姐是打光棍的女生）

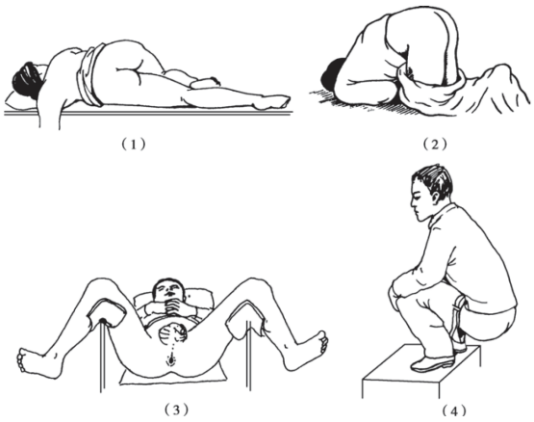


图 41-7　直肠肛管检查体位

(1)左侧卧位　(2)膝胸位　(3)截石位　(4)蹲位

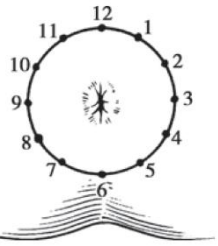
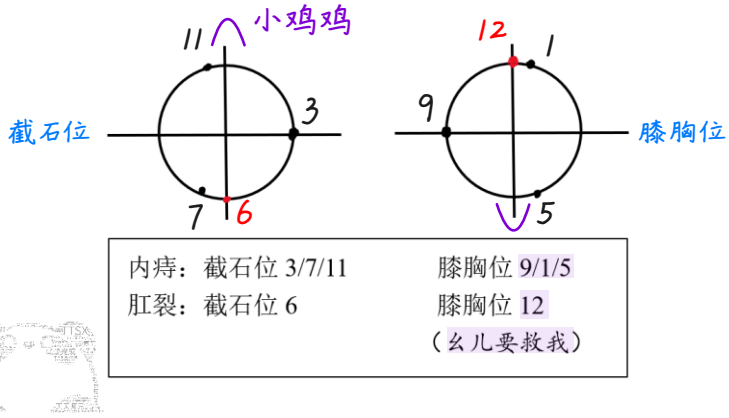


图 41-9　肛门检查的时钟定位记录法(截石位)





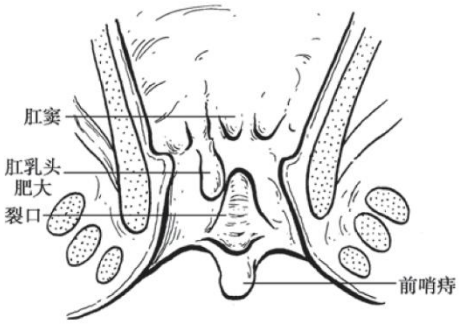


图 41-28　肛裂“三联征”

三、肛裂

①肛管**皮肤**层裂伤后形成的小溃疡 肛管中线是终末动脉,最容易缺血;肛管后面最容易受到摩擦

②肛管**后正中**线：**截石位 6 点/膝胸位 12 点**（肛门在后面、石榴）。若侧方出现肛裂应想到**克罗恩病**等肠炎、肿瘤

③多见于青壮年**便秘** 与便秘相关:乙状结肠扭转(老年人便秘+体位改变)

④**排便剧痛→间歇期不痛→肛管内括约肌痉挛痛**，多有**鲜血** 内痔:出血、脱出、一般无痛(齿状线以上)
肛裂:周期性疼痛(最重要的特点)、出血

⑤**三联征**：肛裂、前哨痔/皮垂、肛乳头肥大（前列腺肥大）
静脉淋巴回流受阻　水肿　机械的力量造成局部坏死

⑥首选保守治疗（高锰酸钾坐浴、润便、扩张），无效手术（肛裂切除术、肛管内括约肌切断术、挂线术）
杀菌　便秘会形成恶性循环　扩张肛管内括约肌

内括约肌:平滑肌、不受意识支配
外括约肌:骨骼肌、控制排便
切外括约肌→大便失禁